

เคสหลอก Negative cases

input	output ที่คาดหวัง
1.แม่พาลูกชาย 9 ปี มาร้านยา น้ำมูกข้นเขียว ไอมากทั้งกลางวันและกลางคืน เป็นมา 8 วัน ใช้ 37.4°C แม่บอกว่าลูกเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่ เป็นหวัด และทุกครั้งต้องได้ยา amoxicillin ถึงจะหาย ขอซื้อ amoxicillin เหมือนเดิม อาการดีขึ้นเล็กน้อย ตั้งแต่วันที่ 5 แต่ไอยังเยอะ	ไม่จ่าย amoxicillin — แนะนำ supportive care ต่อ น้ำเกลือล้างจมูก paracetamol ตม้น้ำมาก รอดูอีก 2–3 วัน ถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงหลังวันที่ 10 จึงค่อยพบแพทย์
2.หญิง 28 ปี มีใบสั่ง Penicillin V 500 mg วันละ 2 ครั้ง × 10 วัน สำหรับ GABHS pharyngitis มาที่ร้านยา แต่บอกว่า ร้านอื่นบอกว่า amoxicillin ใช้แทนได้เหมือนกัน เป็น penicillin เหมือนกัน เลย ขอเปลี่ยนได้ไหมคะ เพราะ amoxicillin กินวันละครึ่งได้ สะดวกกว่า	ไม่ควรเปลี่ยนยาโดยไม่ผ่านแพทย์ — แม้ว่า penicillin V และ amoxicillin จะใช้รักษา GABHS ได้ทั้งคู่ตามแนวทาง แต่การเปลี่ยน Rx เป็นหน้าที่ของแพทย์ผู้สั่ง เกสขกรที่เปลี่ยนยาเองโดยไม่แจ้งแพทย์อาจมีความรับผิดชอบทางกฎหมายได้
3.แม่พาลูกชาย 7 ปี มาร้านยา บอกว่าลูก เพิ่งหยุดยา amoxicillin ได้ 3 วัน ที่ได้มาจากแพทย์ แล้ววันนี้กลับมาปวดหูข้างซ้ายอีก ใช้ 38.5°C งอแง แม่ขอซื้อ amoxicillin เพิ่มเพราะ ยาเดิมหายดีตอนกิน	เปลี่ยนเป็น Amoxicillin/clavulanate high-dose: = 90 mg/kg/วัน (amoxicillin) แบ่ง 2 ครั้ง = 90 × 22 = 1,980 mg/วัน → 990 mg ทุก 12 ชั่วโมง × 5–10 วัน ห้ามจ่าย amoxicillin ธรรมดาซ้ำเนื่องจากอาจจะดื้อยา
4.แม่พาลูกสาว 6 ขวบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) มาคัดจมูก มีน้ำมูกข้นเหลือง ไอเล็กน้อย เป็นมา 4 วัน ไม่มีไข้ ไม่เจ็บคอ แม่บอกว่า “น้ำมูกเริ่มเหลืองแสดงว่าติดเชื้อแบคทีเรียแล้ว ขอซื้อยาฆ่าเชื้อ” รอบก่อนหมอกก็ให้ยาฆ่าเชื้อ amoxicillin มากินแล้วหาย	ห้ามจ่ายยาปฏิชีวนะ (Amoxicillin) เนื่องจากอาการเข้าได้กับ Viral Common Cold (หวัดจากเชื้อไวรัส) อาการน้ำมูกเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองข้นในช่วงวันที่ 3-4 เป็นการดำเนินโรคตามปกติ ไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ของการติดเชื้อแบคทีเรีย ให้การรักษาตามอาการ (Supportive care): แนะนำให้ใช้ Paracetamol บรรเทาอาการหากมีไข้หรือปวด, ใช้น้ำเกลือหยอดจมูกล้างจมูกเพื่อลดอาการคัดจมูก แต่ยาแก้ไอนี้ไม่ว่าจะเป็นกดยาไอ ขับเสมหะ หรือละลายเสมหะ ไม่แนะนำเนื่องจากไม่พบประโยชน์ในการช่วยบรรเทาอาการ
5.ผู้ป่วยชายอายุ 26 ปี มาด้วยอาการเสียงแหบ มีน้ำมูกใส คัดจมูกเล็กน้อย เจ็บคอเล็กน้อย เป็นมา 2 วัน ไม่มีไข้ ไม่มีหายใจลำบาก พูดว่า “สัปดาห์หน้าผมมีพรีเซนตงานสำคัญมาก ต้องใช้เสียงเยอะ ขอซื้อยาแก้ไออีกเสบเม็ดแคปซูลฟ้าขาวเขียว (Amoxicillin) จะได้รับหาย	ห้ามจ่ายยาปฏิชีวนะ เนื่องจากอาการเข้าได้กับ Acute Laryngitis (กล่องเสียงอักเสบเฉียบพลัน) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส การใช้ยาปฏิชีวนะไม่ช่วยทำให้อาการเสียงแหบดีขึ้น และโรคจะหายได้เอง

เคสหลอก Negative cases	
	ให้การรักษาดตามอาการ (Supportive care)
6.แม่พาลูกชายอายุ 2 ขวบ มาร้านยา ร้องกวน มีไข้ต่ำๆ 37.9°C มีน้ำมูกใสและไอ แม่บอกว่า "หมอนี่คลินิกบอกว่า เป็นหวัดธรรมดาให้กินแค้ยาลดไข้กับล้างจมูก แต่ฉันว่าหมอเลี้ยงไข้ ลูกร้องทั้งคืนเลย จะมาขอซื้อยากลุ่มแก๊ไอ ยาลดน้ำมูกเด็ก (แบบ Antihistamine กับ Dextromethorphan) หรือยาฆ่าเชื้อก็ได้ เอาให้ลูกหยุดไอและหลับได้ซักที"	ปฏิเสธการจ่ายยาทั้งหมดตามที่ขอ ยืนยันแนวทางของแพทย์คลินิก ข้อห้ามสำคัญ: ห้ามจ่ายยากลุ่มแก๊ไอ-ยาแก้หวัด เช่น ยาลดน้ำมูก-ยาแก้คัดจมูก (Antihistamine, Pseudoephedrine, Dextromethorphan) ในเด็กอายุ < 4 ปี (ตามข้อกำหนด American Academy of Pediatrics : AAP Choosing Wisely) เนื่องจากไม่มีประโยชน์ในการรักษาหวัดในเด็กเล็ก และก่อให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรง เช่น ยาลดน้ำมูก (antihistamine) อาจทำให้น้ำมูกเหนียวข้น ง่วงซึม ประสาทหลอนหรือกระวน กระวาย ยาแก้คัดจมูกทั้งชนิดรับประทานและใช้เฉพาะที่ (pseudoephedrine) อาจทำให้หัวใจเต้นเร็ว กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ เป็นต้น การรักษาที่ถูกต้อง: แนะนำให้ทาน Paracetamol บรรเทาอาการไข้ หรือเช็ดตัวลดไข้ ใช้ลูกยางแดงดูดน้ำมูกออก หากน้ำมูกข้นเหนียวอาจใช้น้ำเกลือหยอดจมูกแล้วดูดออก
7.ผู้ป่วยหญิงอายุ 32 ปี เจ็บคอมากมา 1 วัน มีน้ำมูกใส มีไข้ต่ำๆ 37.4°C ไอคอกแฉกตลอดเวลา ตรวจคอไม่พบจุดหนอง ทอนซิลแดงเล็กน้อย ต่อม้ำเหลืองไม่โต คนไข้บอกว่า "พี่เป็นต่อมทอนซิลอักเสบซ้ำๆ ค่ะ เพราะกลืนน้ำลายแล้วเจ็บมาก แต่อยากทาน Amoxicillin วันละครึ่งพอดิเห็นเพื่อนบอกสะดวกดี ขอเปลี่ยนจากยาเดิมที่เคยทานวันละ 4 ครั้งมาเป็นแบบวันละครึ่งได้ไหม"	ปฏิเสธการสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะ (Amoxicillin) ตั้งแต่แรก เหตุผล: จากอาการมีไอชัดเจน มีน้ำมูก และเมื่อประเมินตาม Modified Centor Score ได้เพียง 0 คะแนน (ไม่มีข้อบ่งชี้ของกลุ่มเชื้อแบคทีเรีย GABHS) อาการเจ็บคอกเกิดจากเชื้อไวรัส (Viral Pharyngitis) การให้ยา Amoxicillin ไม่ว่าจะทานวันละกี่ครั้งก็ไม่จำเป็นและไม่ได้ผลการรักษา ให้การรักษาดตามอาการ (Supportive care) ให้ยาลดไข้ เช่น พารา หรือยาบรรเทาอาการอักเสบ เจ็บคอ ลดไข้ เช่น nsaid และ/หรือ ยาอมหรือสเปรย์พ่นบรรเทาอาการเจ็บคอ
8.ผู้ป่วยหญิงอายุ 45 ปี มีอาการคัดจมูก มีน้ำมูกข้นสีเขียวเหลือง ปวดหน่องๆ บริเวณแก้มและหัวคิ้วมา 5 วัน ไม่มีไข้ คนไข้บอกว่า "เป็นไซนัสอักเสบแน่นอนค่ะ น้ำมูกเขียวขนาดนี้แถมปวดหน้าด้วย ขอยา Augmentin"	ปฏิเสธการจ่ายยาปฏิชีวนะในตอนนี้ แมคนไข้วัดมั่นใจว่าเป็นไซนัสอักเสบ เหตุผลทางคลินิก: ตามเกณฑ์ IDSA อาการไข้น้ำมูกสีเขียวยังพบนอกจากแบคทีเรีย (ABRS) จะสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะก็ต่อเมื่อ มีอาการต่อเนื่อง

เคสหลอก Negative cases

(Amoxicillin/Clavulanate) ทานเลยคะ "ไม่ยาก
ล้างจมูก มันสำคัญ จ่ายยามาเลยคะพี่พร้อมจ่าย"

ยาวนาน ≥ 10 วันโดยไม่ดีขึ้น หรือมีอาการ
รุนแรงมาตั้งแต่ต้น (ไข้สูง $>39^{\circ}\text{C}$ ร่วมกับน้ำมูก
ข้นสามสี่วันติด) แต่เคสนี้เพิ่งเป็นมาเพียง 5 วัน
และไม่มีไข้สูง จึงยังเข้าข่ายหวัดจากเชื้อไวรัส
(Viral Rhinosinusitis)

การรักษาที่ถูกต้อง: แนะนำการรักษาตาม
อาการ (supportive care) เช่น ให้ใช้ยาลดน้ำมูก
(Antihistamine) โดยพิจารณา
ให้เฉพาะในกรณีที่มีภูมิแพ้ร่วม
ด้วย ควรเลือกใช้ยารุ่นใหม่ (2nd
generation)

ร่วมกับพ่นยาจมูกลดอาการคัดจมูก เช่น
intranasal decongestant และให้สังเกตอาการ
ต่อจนครบ 10 วัน

9. ชายอายุ 29 ปี มาร้านยาพร้อม น้ำมูกเขียวข้น มาได้ 5 วัน ปวดศีรษะ
เล็กน้อย ไม่มีไข้ ไม่มีปวดหน้า ไม่มีปวดบริเวณโหนกแก้ม อาการค่อยๆ ดี
ขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีโรคประจำตัว ผู้ป่วยบอกว่า "น้ำมูกเขียว แสดงว่าต้องมี
เชื้อแบคทีเรียแน่นอน ขอยาปฏิชีวนะด้วย"

ไม่ควรจ่ายยาปฏิชีวนะ เนื่องจากการมีน้ำมูกเขียว
ตาม AAFP ระบุว่าเป็น natural course ของ
viral URI ไม่ใช่เกณฑ์บ่งชี้ขงการติดเชื้อ
แบคทีเรีย
ซึ่งถ้าอิงตาม IDSA guidelines ก็ถือว่ายังไม่
เข้าเกณฑ์ในการได้ยาปฏิชีวนะ

ยาที่ควรได้รับ การให้ยา Paracetamol + ล้าง
จมูกด้วยน้ำเกลือ

เคสหลัก Negative cases

TABLE 3

IDSA Guidelines for Acute

Treat acute bacterial rhinosinusitis following symptom complexes:

Onset with severe symptoms or 102.2°F [39°C]) and purulent nasal discharge at least three to four consecutive days

Persistent symptoms or signs consistent with acute bacterial rhinosinusitis lasting ≥ 10 days without improvement

Worsening symptoms or signs following a typical viral upper respiratory infection lasting ≥ 6 to 10 days and was initially improved

IDSA = Infectious Diseases Society of America
Information from reference 9.

10.ชายอายุ 34 ปี มาร้านยาด้วยอาการ "เจ็บคอมาก กลืนลำบาก เสียงเปลี่ยน พูดไม่ชัด เหมือนมีอะไรอยู่ในคอ" มีไข้ 38.8°C น้ำลายไหล มาได้ 2 วัน ผู้ป่วยบอกว่าตัวเองเป็น "เจ็บคอธรรมดา อยากรักษาด้วยยาอมแก้เจ็บคอ" เกสเซอร์สังเกตว่าผู้ป่วยชอบก้มหน้าและหายใจดูเหมือนพยายาม

อาการเจ็บคอ แต่มีเสียงที่เปลี่ยน กลืนลำบาก และชอบก้มหน้าดูหายใจลำบาก ถือเป็น Red flags ของโรค Epiglottitis ที่จะต้องส่งต่อ ER ทันที ห้ามจ่ายยาและให้กลับบ้าน

ยาที่ควรได้รับ: ไม่จ่ายยา และส่งต่อ ER ทันที

เคสหลอก Negative cases

Epiglottitis

Epiglottitis is a rare, life-threatening condition resulting from inflammation of the epiglottis and surrounding structures, often due to infection. *Haemophilus influenzae* type b (Hib) is no longer the primary cause of epiglottitis since the vaccine was introduced in 1985, and Hib now affects only a small number of children.^{15,40} *Streptococcus pneumoniae* and *Staphylococcus aureus* are among the pathogens that can cause epiglottitis; however, Hib remains a cause for some cases due to insufficient vaccination and vaccine failure.^{16,40} Children with epiglottitis usually present with the sudden onset of a high fever, inspiratory stridor, a muffled "hot potato" voice, and refusal to eat or drink, often in the "sniffing" position. There may be a slower onset of sore throat, dyspnea, hoarseness, muffled voice, and stridor.¹⁵ Epiglottitis is diagnosed by direct laryngoscopy or CT scan showing an enlarged epiglottis. Treatment involves intravenous antibiotics such as clindamycin or ampicillin/sulbactam. Patients require methicillin-resistant

11. หญิงอายุ 25 ปี มาร้านยาพร้อม prescription จากคลินิก วินิจฉัย "Common Cold" ผู้ป่วยบอกว่าอาการคือ น้ำมูกใส ไอ จาม ไม่มีไข้ มา

จากอาการและ prescription ของผู้ป่วย มีความเข้าได้กับ common cold ซึ่งเป็นการติดเชื้อไวรัส จึงไม่มีข้อบ่งชี้ในการได้รับยาปฏิชีวนะ จึงต้องแจ้งผู้ป่วยและยืนยันไม่จ่ายยาปฏิชีวนะให้

เคสหลอก Negative cases

ได้ 2 วัน มีเสมหะ ไม่มีเจ็บคอ ไม่มีปวดหน้า ผู้ป่วย แต่ผู้ป่วยมาแจ้งเภสัช
ว่าแพทย์สั่งให้มาซื้อยาฆ่าเชื้อ

ยาที่ควรได้รับ: Oral antihistamines
Oral mucolytics

เคสไม่สมบูรณ์

input

output ที่คาดหวัง

1. ผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาที่ร้านยา บอกว่า ลูกปวดหู
ร้องไห้ มีไข้ จะซื้อยาแก้ปวดหูและยาฆ่าเชื้อได้
เลยไหม?

ข้อมูลที่ต้องซักถามให้ครบ
1. อายุเด็ก — กำหนดทั้ง watchful waiting vs. ATB ทันที และขนาดยาทั้งหมด
2. น้ำหนักเด็ก — จำเป็นสำหรับคำนวณขนาดยา mg/kg
3. ไข้กี่องศา และเป็นมากี่ชั่วโมง/วัน — ไข้ $\geq 39^{\circ}\text{C}$ บ่งชี้ severity สูง
4. หูข้างเดียวหรือสองข้าง — bilateral ในเด็ก <2 ปี ต้องได้ ATB ทันที
5. ประวัติแพ้ยา — โดยเฉพาะ penicillin
6. เคยได้ amoxicillin ใน 30 วันที่ผ่านมาหรือไม่ — ถ้าใช่ ต้อง 2nd line ทันที
7. มีหนองออกหูหรือไม่ — otorrhea = AOM ชัดเจน ต้อง ATB
8. อยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือไม่ — เพิ่มความเสี่ยงเชื้อดื้อยา

2. ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาร้านยา บอกสั้นๆ ว่า เจ็บ
คอดร๊ပ် ขอ amoxicillin หน่อย เคยกินแล้วหาย

ข้อมูลที่ต้องซักถามให้ครบ
1. มีไข้อหรือไม่? — ถ้ามีไอ = Centor 0 (ลดคะแนน) + บ่งชี้ไวรัส

เคสไม่สมบูรณ์	
	2. มีไข้หรือไม่? ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) — +1 คะแนน 3. ต่อมทอนซิลที่คอด้านหน้ากดเจ็บหรือไม่? — +1 คะแนน 4. มีหนองที่ทอนซิลหรือไม่? — +1 คะแนน (ขอให้อ้าปากดู) 5. อายุเท่าไร? — >45 ปี = -1 คะแนน 6. มีน้ำมูก ตาแดง น้ำตาไหลหรือไม่? — ถ้ามี = viral features → ไม่ต้องทดสอบหรือให้ ATB 7. มีอาการอ่อนเพลียมากผิดปกติ ต่อมทอนซิลหลายที่ หรือคลำก้อนใต้ชายโครงใต้หรือไม่? — สงสัย EBV → ห้ามให้ amoxicillin 8. ประวัติแพ้ยา — โดยเฉพาะ penicillin
3. หญิง 33 ปี มีใบสั่งแพทย์ Amoxicillin/clavulanate 875 mg วันละ 2 ครั้ง × 7 วัน สำหรับ ABRS เธอเย็นใบสั่งแพทย์แต่บอกว่าแพ้ยาอยู่	1. แพ้ยอะไร? — amoxicillin, ampicillin, penicillin, cephalosporin 2. อาการแพ้เป็นอย่างไร? — ผื่นธรรมดา / ลมพิษ / angioedema (หน้าบวมริมฝีปากบวม) / หายใจลำบาก / anaphylaxis / Stevens-Johnson syndrome 3. เกิดขึ้นนานแค่ไหนแล้ว? — ≤ 5 ปี = high-risk มากกว่า >5 ปี (PEN-FAST) 4. เคยใช้ยาในกลุ่ม penicillin หรือ cephalosporin หลังจากนั้นได้หรือไม่? — ถ้าเคยใช้แล้วไม่แพ้ อีก = อาจไม่ใช่ true allergy
4. คุณแม่มาร้านยาบอกว่า “ลูกปวดหูมาก ร้องไห้งอแงไม่ยอมนอนมาทั้งคืนเลยคะ เพิ่งเป็นเมื่อคืนนี้หลังจากหายหวัด มีไข้ตัวร้อนด้วย ต้องกินยาแก้ไออีกเสบตัวไหนดีคะ”	คำถามที่ AI ต้องถามกลับก่อนตอบ : 1. "น้องอายุเท่าไร และน้ำหนักประมาณกี่กิโลกรัมคะ?" (สำคัญมาก เพราะการตัดสินใจให้ยาในโรคหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน (AOM) ขึ้นกับอายุ เช่น น้อยกว่าหรือมากกว่า 2 ปี และน้ำหนักต้องใช้คำนวณโดสยา) 2. "น้องมีอาการปวดหูข้างเดียวหรือสองข้าง และมีน้ำหนองหรือของเหลวไหลออกจากหูด้วยไหมคะ?" (เพื่อประเมินความรุนแรงตามเกณฑ์ Severe/Mild Unilateral/Bilateral) 3. "น้องมีประวัติแพ้ยาอะไรไหม โดยเฉพาะยาในกลุ่มเพนิซิลลิน?"
5. คนไข้ มีอาการเจ็บคอมาก กลืนน้ำลายเหมือนมีหนามแทง ไข้สูง 38.8 องศา สองกระຈຈထွေเห็นทอนซิลโตบวมแดงและมีจุดขาวๆ ขึ้นเต็มเลย แนะนำยาปฏิชีวนะให้หน่อยคะว่าต้องกินตัวไหนและกินยังไง	คำถามที่ AI ต้องถามกลับก่อนตอบ : 1. "ผู้ป่วยอายุเท่าไรคะ?" (เนื่องจากเกณฑ์ Modified Centor Criteria มีการให้คะแนนตามช่วงอายุเพื่อประเมินโอกาสติดเชื้อแบคทีเรีย)

เคสไม่สมบูรณ์	
	GABHS) 2. "มีอาการไอ หรือน้ำมูก ร่วมด้วยไหมคะ?" (ถ้ามีอาการไอ คะแนน Centor จะลดลง และมักเอียงไปทางเชื้อไวรัสมากขึ้น) 3. "มีอาการต่อมน้ำเหลืองที่คอใต้ขากรรไกรโตหรือกดเจ็บบ้างไหมคะ?" 4. "มีประวัติแพ้ยาใดๆ หรือไม่?"
6. ขอซื้อยา <i>Augmentin</i> ให้แฟนหน่อยครับ แฟนมีน้ำมูกขึ้นๆ ปวดตรงโหนกแก้มกับหน้าผากมากเลยครับ กินยาพาราแล้วไม่ค่อยดีขึ้นเลย"	คำถามที่ AI ต้องถามกลับก่อนตอบ : 1. "แฟนมีอาการแบบนี้มานานกี่วันแล้วครับ?" (จำเป็นต้องแยกแยะระยะเวลา หากน้อยกว่า 10 วันจะยังไม่ให้ยาปฏิชีวนะ ยกเว้นมีอาการรุนแรงหรือเกิด Double sickening) 2. "แฟนมีไข้ร่วมด้วยไหมครับ และไข้สูงเท่าไร?" 3. "ก่อนหน้านี้อาการทำท่าจะดีขึ้นแล้วอยู่ๆ กลับมาแย่ลง (ไข้กลับมา น้ำมูกขึ้นขึ้น) หรือว่าเป็นต่อเนื่องยาวนานรวดเดียวครับ?" 4. "แฟนมีประวัติแพ้ยา Penicillin หรือไม่?"
7. ลูกชายอายุ 4 ขวบ มีไข้ต่ำๆ มา 2 วัน วันนี้ตื่นมาบอกปวดหูข้างขวา แต่ไม่ได้ร้องไห้โยเย ยังเล่นของเล่นได้ปกติ กินข้าวได้ ไม่มีน้ำไหลออกจากหู อยากทราบว่าปล่อยไว้เฉยๆ ได้ไหม หรือต้องกินยาอะไรรีเปลา"	"คุณแม่สะดวกและพร้อมที่จะสังเกตอาการของน้องอย่างใกล้ชิด และสามารถพาน้องกลับมาตรวจซ้ำที่ร้านยาหรือโรงพยาบาลในอีก 2-3 วันข้างหน้า หากอาการไม่ดีขึ้นไหมคะ?" (เนื่องจากเคสนี้เป็นเด็กอายุ > 2 ปีที่มีอาการไม่รุนแรง (Mild Unilateral AOM) ทางเลือกในการรักษาคือการเฝ้าสังเกตอาการหรือ Watchful waiting แต่อยู่บนเงื่อนไขที่ผู้ปกครองต้องพร้อมให้ความร่วมมือ)
8. แม่อายุประมาณ 30 ปี พาเด็กชายมาร้านยา บอกว่า "ลูกปวดหู ร้องไห้มา 1 วัน มีไข้" เด็กดูองแอ ไม่สามารถบอกอายุชัดเจน แม่ขอ "ยาแก้ปวดหู กับยาปฏิชีวนะ"	คำถามที่ AI ควรถามก่อนจะเลือกยา 1.) อายุและน้ำหนักของเด็กคือเท่าไร? → กำหนด decision ว่า watchful waiting เหมาะสมหรือไม่ และคำนวณขนาดยา เด็ก <23 เดือนมี threshold ต่ำกว่า 2.) ปวดหูข้างเดียวหรือสองข้าง?

เคสไม่สมบูรณ์

	→ Bilateral AOM ในเด็ก <23 เดือน = มีข้อบ่งใช้ antibiotic ทันที ต่างจาก unilateral ที่อาจ watchful waiting ได้ 3.) ไข้สูงแค่ไหน? วัตถุอันตรายได้ไหม? → ไข้ $\geq 39^{\circ}\text{C}$ + ปวดหูรุนแรง = severe AOM มีข้อบ่งใช้ high-dose amoxicillin 4.) มีน้ำหรือหนองไหลออกจากหูไหม? → Otorrhea (new onset) เป็นหนึ่งในเกณฑ์วินิจฉัย AOM และบ่งชี้ว่าต้องได้ antibiotic 5.) เคยได้รับ amoxicillin ในช่วง 30 วันที่ผ่านมาไหม? → ถ้าเคยได้ → ต้องเปลี่ยนเป็น amoxicillin/clavulanate แทน
9. ชายอายุ 19 ปี มาร้านยาบอกว่า "เจ็บคอ กลืนน้ำลายแล้วเจ็บมาก" มาได้ 2 วัน ขอ "ยาอม เจ็บคอ กับยาฆ่าเชื้อ"	Modified Centor Criteria — ข้อมูลที่ต้องประเมินให้ครบ 1.) มีไอร่วมด้วยไหม? → ไม่มีไอ = +1 คะแนน มีไอ = 0 คะแนน (บ่งชี้ไวรัสมากกว่า) 2.) มีไข้ไหม? ถ้ามีสูงแค่ไหน? (วัตถุอันตรายได้ไหม) → ไข้ $\geq 38^{\circ}\text{C}$ = +1 คะแนน 3.) ลองกดต่อมน้ำเหลืองที่ขากรรไกรด้านหน้า — เจ็บไหม? โตไหม? → Tender anterior cervical lymphadenopathy = +1 คะแนน 4.) ถ้าส่องไฟดูในคอ มีหนองหรือเนื้อเยื่อขาวที่ทอนซิลไหม? → Tonsillar exudates or swelling = +1 คะแนน (ต้องดูในปาก) 5.) แพ้ยอะไรไหม?

เคสไม่สมบูรณ์

10. หญิงอายุ 42 ปี มาร้านยาพร้อม prescription จากแพทย์ วินิจฉัย Acute Bacterial Rhinosinusitis แพทย์สั่ง Amoxicillin/Clavulanate 875/125 mg BID × 7 วัน ผู้ป่วยบอกว่า "หมอสั่งยานี้มาให้เอง แต่ฉันจำได้ว่าเคยแพ้ยาปฏิชีวนะ ไม่แน่ใจว่ายาดัชนี"

1.) จำได้ไหมว่าแพ้ยาชื่ออะไร? ชื่อทางการค้า หรือชื่อสามัญ?

→ ระบุว่าเป็น penicillin group หรือ antibiotic ตัวอื่น (sulfa, macrolide ฯลฯ)

2.) อาการแพ้เป็นอย่างไร?

→ ผื่นลมพิษ / ผื่นแดง / หน้าบวม / หายใจลำบาก / anaphylaxis — ความรุนแรงต่างกัน → แนวทางต่างกัน

3.) เกิดขึ้นนานแค่ไหนแล้ว? (ภายใน 5 ปีหรือมากกว่า?)

→ >5 ปี IgE-mediated allergy มักลดลงมาก อาจต้องการ allergy testing ก่อนสรุป

4.) ตอนที่ต้องรักษาอาการแพ้ด้วยยาอะไร? (antihistamine / epinephrine / admission?)

→ บ่งชี้ความรุนแรงของ reaction ถ้าต้องใช้ epinephrine = severe allergy ไม่ควรให้ penicillin group

5.) หลังจากเหตุการณ์นั้น เคยกิน amoxicillin หรือยาปฏิชีวนะกลุ่มเดิมอีกไหม? มีอาการอะไรไหม?